

Status épaule :

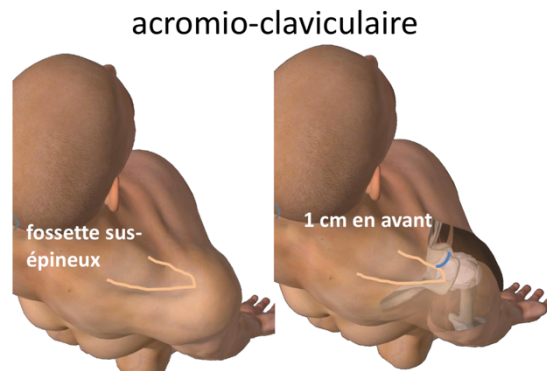
- ⇒ Traumatique : inspection, palpation et rien de plus avant Rx, toujours comparé droite et gauche (fracture, luxation, etc). Permet de déterminer les incidences de Rx à faire.
- ⇒ Douleur chronique → même palpation que traumatique, puis amplitude, test spécifique

1. Inspection :

- Torse nu : voir le dos, omoplate, bras etc → amyotrophie (ex deltoïde, sous-épineux etc), déformation, scapula alata, popeye sign etc

2. Palpation :

- **Articulation acromio-claviculaire +++** : soit on suit la clavicule jusqu'à ce qu'on trouve une « marche d'escalier » (personne mince), soit on palpe la fossette du supra-épineux jusqu'à la pointe du triangle, et l'articulation se trouve 1-2 cm antérieurement → lésion du complexe ligamentaire acromio-claviculaire



- **Gouttière bicipitale +++** : elle se trouve 2-3 cm antérieurement de l'articulation acromio-claviculaire, on sent le tendon rouler sous nos doigts lors de la RE → tendinopathie
- Articulation sternoclaviculaire (rhumatisme, éventuellement traumatisme)
- Coracoïde (attache court chef du biceps, pathologie touche rarement),
- Insertions des sus et sous-épineux : surtout savoir trajet sur scapula, insertion compliquée

(3. **Neuro** (sensibilité, nerf axillaire surtout touché si luxation antérieure) et **vasculaire** si fracture)

4. Amplitude :

- **Actif d'abord et puis passive** (si l'actif est normale, juste mentionner qu'on ne fait pas le passif car tout est bon en actif): **F/E, Abd/Add, RI/RE** (RE : garder le coude le long du corps, RI : monter dans le dos), RI = sommet du pouce (C7 sort le plus). Comme point de repère : quand la main est sur le ventre = RI à 70°.
- **Si bloquer en passif et actif** : capsulite rétractile (épaule gelée) la plus fréquente, arthrose aussi.
- **Si bloqué en actif mais pas en passif** : atteinte para-articulaire (muscle, tendon ou nerf)

5. Tests spécifiques :

- 5 muscles (supra-épineux, infra-épineux, petit rond, subscapulaire, biceps) : test positif (sauf biceps) si le patient n'a plus de force (= tendon coupé, s'il a encore de la force = tendon en continuité), si fait mal → tendinite possible mais on aura le temps de faire d'autres tests (US, IRM), moins urgent. Tandis que si le tendon n'est plus en continuité, il faut aller à la chirurgie rapidement.
- **Supra-épineux** : s'insère sur grande tubérosité, abduction, innervé par n. suprascapulaire
Test de Jobe : pouce vers le bas (évite utilisation du deltoïde), bras à 30° en avant car le muscle est attaché à l'omoplate qui est contre la paroi du thorax à 30° environ, on met donc le muscle est dans la ligne de force, c'est aussi possible que le patient ait un peu plus de force du côté dominant). Tester symétriquement.
- **Infra-épineux** : s'insère sur la grande tubérosité, un peu plus bas que le supra-épineux, RE, innervé par n. suprascapulaire.
RE contre résistance (attention : coude au corps). Tester symétriquement, examinateur derrière le patient.
Signe du portillon : si suspicion rupture complète, fait en passif → les 4 muscles de l'épaule maintiennent l'humérus dans une certaine position, s'il n'y a plus l'infra-épineux, les autres muscles tirent toujours, l'équilibre part plus intérieurement
- **Petit rond** : tubérosité mais partie distale et postérieure, RE en abduction. Innervé par le n. axillaire.

Manœuvre de Patte : abduction 90°, RE contre résistance. Tester un côté après l'autre car besoin parfois de maintien du bras en abduction.

Signe du clairon : il n'y a plus de RE → le patient n'arrive pas à amener la main à la bouche sans lever le coude

- **Sous-scapulaire** : petite tubérosité, adduction et RI, innervé par nn. subscapulaires inférieur et supérieur.

- **Lift-off test de Gerber** (actif) : main dans le dos, résiste contre la force du médecin

- **Belly press** (actif) : si le patient n'arrive pas à mettre la main dans dos à cause de la raideur de l'épaule (lésion présente depuis un moment, a arrêté d'utiliser l'épaule)
→ main sur le ventre, ne doit pas se décoller,

Attention : coude en avant, pas en arrière → adduction et rétropulsion

- **Lag sign de Hertel** (passif) : on décolle la main du dos et la main doit rester décollée

Aucun 100% sensible ou spécifique → faire plusieurs augmentent, en savoir juste un

- **Long chef du biceps brachial** qui passe dans gouttière, innervé par n. musculocutané.

Palm-up test : bras tendu devant lui, le patient a plus mal avec la paume vers le ciel que la paume vers la terre) → positif si douleur dans gouttière (= rupture (signe de Popeye) ou inflammation)

- **Conflit acromial** : distance entre l'acromion et la tête humérus qui est diminuée → irrite tendon → tendinite (test !) → Dégénérescence et rupture

Impingement test de Neer (passif) : bloquer omoplate, avec main en pronation → augmente proximité de la grande tubérosité de l'acromion, ce qui est l'inverse avec la main en supination

Arc douloureux en abduction (actif) : douleur entre 60 et 120° (espace entre tête et acromion le plus petite)

Signe de Hawkins (passif) : bras à 90° antérieurement, rotation interne → douleur

6. Laxité (tiroir + sillon) + Instabilité : test d'appréhension,

- Laxité : objectif → on recherche un tiroir antérieur car souvent l'humérus se luxé en avant, on a une laxité si asymétrie entre gauche et droite.

- Instabilité = subjectif → lutte contre notre mouvement